



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : غنيه كواس عطيت الله +++++

العنوان : +++

الحى / المدينة : العمرانيه

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستماره : 27-09-2026

رقم البطاقة : 27102112601065 رقم التليفون : 01212163766

العمر (تاريخ الميلاد) : 11-02-1971 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----

التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: غنيه كواس عطيت الله ++++ National ID: 27102112601065	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Patient Name	: الأستاذة / غنية كواس عطيت الله مرسى	Request No.	: 13002520
Patient No.	: 27102112601065	Request Date	: 22/10/2022
Path No.	: 3126/22	Verification Date	: 26/10/2022
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast mass.

Nature of the specimen:
Tru cut biopsy collected at 20/10/2022.

Gross Examination:
• Multiple grathish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Microscopic examination:
• Histological type: Invasive duct carcinoma.
• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1).
• Lymphovascular emboli: No in the received material.
• Ductal carcinoma in situ: No in the received material.

Diagnosis:
Left breast mass; Tru cut biopsy:
• Invasive duct carcinoma GII.
• For IPT (ER, PR, Her2 and Ki67).

Prof. Gamal Abdellatty.
Dr. Marwa Mahmoud.

Verified by :



Name: غنية كواس عطية الله		
MR. : 4212		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was diagnosed with left breast cancer, staged as clinical T2 N1 M0, with estrogen and progesterone receptor positivity and HER2 negativity. An upfront modified radical mastectomy (MRM) was performed, revealing pathologic stage pT2 N1. The treatment plan included adjuvant chemotherapy and placement of a port, along with aromatase inhibitor therapy (Arimidex) and supplemental therapy. At the most recent visit, the patient continued on Arimidex and supplemental therapy, scheduled to be administered for three months with a follow-up clinic appointment after the three-month period.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name	: الأستاذة / غنية كواس عطيت الله مرسى	Request No.	: 13002520
Patient No.	: 27102112601065	Request Date	: 22/10/2022
Birth No.	: 3126/22	Verification Date	: 03/11/2022
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

clinical Data:
Left breast mass.

History of the specimen:
Tru cut biopsy collected at 20/10/2022.

Gross Examination:
Multiple whitish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
Histological type: Invasive duct carcinoma.
Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1).
Lymphovascular emboli: No in the received material.
Ductal carcinoma in situ: No in the received material.
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 7/8)
HER-2: No membrane reaction of tumor cells (score 0)
Ki67: 25 % nuclear reaction

Diagnosis:
Left breast mass; Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma GII.
ER : Positive (8/8)
PR : Positive (7/8)
HER2 : Negative (score 0)

Verified by :



atient Name الأستاذه / غنية كواس عطيت الله مرسى
atient No. 27102112601065
ith No. 3126/22
ex Female
ge 51 Y
efferreing Doc.

Request No. 13002520
Request Date 22/10/2022
Verification Date 03/11/2022
Financial Category جوستاف روسي - مبادره
Department Out Patient

Registered by .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

KI67: 25%

Prof. Gamal Abdellatty

Dr. Marwa Mahmoud.

Verified by :



Patient Name : الأستاذة / غنية كواس عطيت الله مرسى :	Request No. : 13004054
Patient No. : 27102112601065	Request Date : 05/12/2022
Path No. : 3665/22	Verification Date : 18/12/2022
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Age : 51 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

(Amended Report)

Clinical Data: Left breast cancer .

Nature of the specimen: Left breast & Left axilla (MRM)

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM
- measured 24x13x4cm with covering skin ellipse measured 24x13 cm .
- Localization: UOQ
- Tumor extent : A greyish white firm mass
- Size: mass 2.5x1x1 cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size: 14L.Ns up to 1x0.5cm .

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma .
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: Focal (5%)
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive L.Ns (3/14) with extracapsular extension
- Resection Margins: Free margins.

Diagnosis:

Left Breast, Left MRM :

- Invasive duct carcinoma grade II .
- Focal DCIS
- Free margins
- Free nipple and areola

Verified by :





Patient Name: Ghaneya Koas Alit Allah Morsi	Date : 06/11/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 51 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 21632

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Left breast UIQ focal asymmetry measuring about 2.6 x 2.4 cm.
- Few enlarged left axillary lymph nodes largest measuring 1.4 x 0.8 cm.
- Middle lobe, lingula and bilateral lower lobes atelectatic bands.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Heterogenous thyroid gland with bilateral hypodense nodules.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with low CT attenuation denoting fatty infiltration. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Right renal para pelvic simple cyst.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Ghaneya Koas Atit Allah Morsi	Date : 06/11/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 51 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 21632

- Right adenxal simple cyst measuirng 3.3 x 2.6 cm.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- No suspicious osseous lesions.

Opinion:

- Left breast lesion with left axillary lymph nodes as described for correlation with sonomammography.
- No evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastasis.

Dr. Ali Saber, MSc.

Dr. M. Gomaa, M.D.



Exam Information:

<u>Patient Name:</u> A K	<u>Date of birth:</u> 11/02/1971
<u>Arabic Name:</u> غنية كواس	<u>Patient Gender:</u> F
<u>Patient RIS ID:</u> 333580 <u>Patient HIS ID:</u> 123015840	<u>Exam Date:</u> 06/08/2023
<u>Written by:</u> Dr. Hoda Fathy	<u>Approved by:</u> Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (06/08/2023)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP
Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Omnia Talaat.MD

Mayadah Ashraf
Rawan Mohammed